LES ÉCOLOGISTES
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

LIVRET THÉMATIQUE

PRENDRE SOIN DE NOTRE SANTÉ REPRODUCTIVE

Connaître son corps. Prévenir. Choisir. Être soigné·e.



Campagne de Marine Tondelier
Septembre 2026

DÉFINITION : La santé reproductive désigne le bien-être physique, mental et social dans tout ce qui concerne le système reproducteur, ses fonctions et son fonctionnement. Elle ne se limite pas à l'absence de maladie : elle inclut la possibilité d'une vie sexuelle sûre et la liberté de décider si, quand et à quelle fréquence avoir des enfants.

TABLE DES MATIÈRES

Édito..... 4
Repères chiffres..... 7
Mesures clés..... 8
Avant la naissance et enfance..... 11
Focus : Santé reproductive, climat et biodiversité..... 14
Puberté et adolescence 18
Vie adulte..... 22
Focus : Santé reproductive masculine..... 26
Désir d'enfant et fertilité..... 29
Focus : Cancer et santé reproductive..... 34
Grossesse, maternité et post-partum..... 37
Insuffisance ovarienne prématurée, périménopause, ménopause et andropause..... 43
Focus : Inégalités raciales, sociales et territoriales de santé reproductive..... 47

ÉDITO

Prendre soin de notre santé reproductive à chaque âge de la vie

Le débat politique se préoccupe bien peu des questions reproductives - ou alors mal. Pourtant, elles concernent de nombreux et nombreuses Français.es. Nous faisons le choix de la mettre au premier plan : la santé reproductive est un enjeu de liberté, d'égalité, de santé publique et d'écologie.

Notre santé reproductive ne se limite pas à la fertilité et ne s'arrête pas avec la ménopause.

Elle se construit même avant la naissance : chez le fœtus féminin, la réserve ovocytaire se constitue pendant la vie intra-utérine. Elle évolue ensuite avec l'enfance, la puberté, notre sexualité, notre contraception, nos choix reproductifs, nos maladies, parfois un projet d'enfant, une grossesse ou une perte de grossesse, puis la périménopause, la ménopause, l'andropause et le vieillissement.

Elle concerne les femmes comme les hommes.

Pourtant, notre système de santé continue trop souvent à considérer nos corps de manière fragmentée et à n'agir qu'une fois les problèmes installés. Trop tard face aux règles incapacitantes. Trop tard pour diagnostiquer certaines pathologies. Trop tard lorsque l'infertilité est découverte au moment d'un projet d'enfant. Trop tard encore lorsque surviennent des bouleversements hormonaux que l'on ne comprend pas et auxquels on n'a pas été préparée.

Car derrière ces mots, il y a des réalités qui peuvent bouleverser une vie. Des douleurs que l'on finit par croire normales. Un corps qui change sans que l'on comprenne pourquoi. Un désir d'enfant qui se heurte à l'infertilité, aux examens, aux traitements et parfois aux échecs. Des bouleversements hormonaux qui affectent le sommeil, l'humeur, la sexualité, l'énergie ou le

rapport à son propre corps. **Lorsque notre santé reproductive vacille, c'est une part très intime de soi, de son identité et de ses projets qui est ébranlée.**

Ces épreuves ne doivent plus être vécues dans le silence, la culpabilité ou avec le sentiment qu'il faudrait simplement « faire avec ». Elles méritent d'être comprises, reconnues et prises en charge.

Nous voulons changer d'ère et revoir à 360° notre vision de la santé reproductive : passer d'une politique centrée sur la procréation à une véritable politique de santé reproductive tout au long de la vie, qui articule prévention, soins, libertés, conditions de vie et santé environnementale.

Les parcours doivent être conçus à partir des personnes et de leur vie réelle, et non comme une succession de prises en charge cloisonnées : de la prévention au diagnostic, du soin au suivi, de la santé au travail à l'exposition environnementale, chaque étape doit être coordonnée et accessible.

Cela signifie mieux connaître son corps, prévenir plutôt que réparer, diagnostiquer plus tôt, mieux soigner et donner à la recherche biomédicale les moyens de rattraper des décennies de retard.

Cela signifie aussi garantir notre liberté.

Avoir un enfant ou ne pas en avoir. Choisir sa contraception. Pouvoir interrompre une grossesse. Être accompagné·e lorsque la fertilité est altérée. Pouvoir accoucher dans la sécurité et le respect.

Préserver la fertilité ne signifie pas prescrire la parentalité. La réponse politique à la baisse de la natalité ne peut pas être l'injonction d'avoir des enfants. Elle est de permettre à chacune et chacun de mener librement son projet de vie.

Et parce que nous sommes Écologistes, nous affirmons que la santé de nos corps dépend aussi des milieux dans lesquels nous vivons : une politique féministe du vivant relie santé, libertés, justice sociale et protection de l'environnement.

Pesticides, perturbateurs endocriniens, PFAS, pollution, substances reprotoxiques au travail, dérèglement climatique : on ne choisit ni l'air que l'on respire, ni toutes les substances auxquelles on est exposé.e..

Soigner les corps, c'est d'abord agir sur ce qui les rend malades.

C'est enfin adapter notre société à la réalité de nos corps : à l'école, dans notre système de soins comme au travail. Menstruations incapacitantes, pathologies gynécologiques, AMP, grossesse, post-partum, périménopause ou ménopause ne doivent plus conduire les personnes à choisir entre leur santé, leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Et il faut donner à la recherche les moyens de comprendre ce que nous ne savons pas encore et d'améliorer ce qui a été trop longtemps négligé. Les inégalités de recherche touchent particulièrement la santé des femmes : douleurs, pathologies, dispositifs médicaux et traitements ont trop souvent été moins étudiés ou moins innovants. Investir dans la recherche, c'est aussi moderniser les outils et pratiques lorsque des solutions plus respectueuses et moins douloureuses peuvent être développées.

La recherche a un coût. Mais le sous-investissement coûte bien plus cher.

La santé reproductive est intime. Mais les conditions qui permettent de la préserver sont profondément politiques.

Changer d'ère, c'est aussi réconcilier la médecine et les patient·es : mieux écouter les symptômes et l'expérience vécue, partager l'information et les décisions, et restaurer une relation de confiance fondée sur le consentement, le respect et la décision médicale partagée.

Avec ce livret, nous faisons un choix simple : **permettre à chacune et chacun, à chaque âge de la vie, de connaître son corps, de préserver sa santé et de décider librement de sa vie reproductive.**

C'est le sens de nos propositions : **passer de la procréation à la santé reproductive, du soin tardif à la prévention, d'une responsabilité reposant essentiellement sur les femmes à une responsabilité partagée, et des seuls comportements individuels à une responsabilité collective, sociale et environnementale.**

Parce que prendre soin de notre santé reproductive, c'est aussi prendre soin de notre liberté.

Marine Tondelier, Secrétaire nationale Les Écologistes
Anne Souyris, Sénatrice de Paris
Majdouline Sbaï, Députée européenne
Marion-Emi Alix, Conseillère de Paris et co-fondatrice de l'association Fertéa Santé

REPÈRES CHIFFRÉS

4 FEMMES SUR 10
souffrent de douleurs menstruelles modérées à sévères.
(Source : Plan International)

43,3 % DES ADOLESCENTES
ont déjà manqué l'école à cause de douleurs de règles.
(Source : Plan International)

1 FEMME SUR 10
est concernée par l'endométriose.
(Source : EndoFrance)

≈ 1 500 CAS PAR AN :
de puberté précoce centrale idiopathique.
(Source : Santé publique France)

10 À 13 % DES FEMMES
sont concernées par le SOPK/SOMP (syndrome ovarien métabolique et polyendoctrinine)
(Source : Inserm)

+36 %
Hausse du taux d'incidence standardisé du cancer du sein entre 1990 et 2023.
(Source : Santé Publique France)

PLUS D'1 FEMME SUR 3
présente une souffrance psychique deux mois après l'accouchement.
(Source : Santé Publique France)

PLUS DE 3 MILLIONS DE PERSONNES ***sont concernées par l'infertilité en France.***
(Source : Santé.gouv)

≈ -50 % ***Baisse de la concentration spermatique moyenne depuis les années 1970.***
(Source : Inserm)

17,2 MILLIONS DE FEMMES DE PLUS DE 45 ANS ***sont concernées par les enjeux liés à la*** **ménopause** ***prématurées.***
(Source : Has Santé)

+26 % ***association entre les vagues de chaleur et les naissances.***
(Source : GeoHealth)

La mortalité périnatale est de **17,6 % DANS LE DROM CONTRE 10,8% EN MÉTROPOLE.**
(Source : Drees)

10 MESURES PHARES

Protéger notre santé reproductive contre les pollutions et le changement climatique.

Réduire à la source l'exposition aux perturbateurs endocriniens, PFAS, pesticides et substances reprotoxiques au travail comme dans la vie quotidienne. Intégrer la santé reproductive aux politiques d'adaptation climatique, notamment face aux fortes chaleurs pendant la grossesse.

Objectif : passer d'un droit théorique à l'adaptation du poste à une protection réellement contrôlée et accessible.

Autoriser le DPI-A (Diagnostic Préimplantatoire des Aneuploïdies) dans des indications médicales ciblées.

Permettre l'analyse de l'euploïdie (c'est-à-dire la présence d'un nombre normal et complet de chromosomes dans une cellule) afin d'apporter une information sur le potentiel implantatoire des embryons, notamment dans certaines situations médicales, dans un cadre éthique et médical clairement défini.

Objectif : réduire les transferts infructueux et mieux informer les personnes engagées dans une FIV sans confondre euploïdie et viabilité de l'embryon.

Faire à l'adolescence le premier grand rendez-vous de santé reproductive.

Garantir partout une EVARS (Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité) réellement effective, avec des heures banalisées dans les emplois du temps, un budget dédié et un cadre national commun à tous les établissements. Prévoir des séances mixtes et, lorsque les sujets le justifient, des temps en groupes séparés permettant une parole plus libre. Faire intervenir des professionnel·les formé·es, notamment des professionnel·les de santé et de la psychologie. Renforcer l'éducation à la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV), à son rôle dans la prévention de plusieurs cancers et à l'importance d'une vaccination complète.

Objectif : que la qualité de l'éducation à la santé reproductive ne dépende plus de l'établissement fréquenté.

Mettre fin à l'errance diagnostique des principales pathologies de santé reproductive.

Étendre aux autres pathologies gynécologiques et reproductives le travail engagé avec la stratégie nationale contre l'endométriose : SOMP (syndrome métabolique ovarien polyendocrinie), adénomyose, fibromes, insuffisance ovarienne prématurée et pathologies reproductives masculines. Distinguer le délai avant la première consultation, à réduire par l'information et un meilleur accès aux soins sur tout le territoire,, du délai entre la première consultation et le diagnostic, qui doit tendre vers zéro grâce à la formation des professionnel·les et à des parcours structurés.

Objectif : qu'une personne qui consulte pour des symptômes évocateurs soit orientée sans délai vers le bon diagnostic.

Faire du post-partum une période de soins, de temps et de soutien à part entière.

Garantir pendant la première année un parcours de santé physique, gynécologique, sexuelle et psychique, un accompagnement concret après la naissance et une organisation du travail et des congés permettant aux parents de s'occuper de leur enfant sans perte de droits ni choix contraint par le revenu.

Objectif : garantir une continuité réelle entre soins, parentalité et vie professionnelle.

Faire de l'insuffisance ovarienne prématurée, de la périménopause et de la ménopause de véritables enjeux de santé publique

Garantir des parcours adaptés à ces situations distinctes et prendre en compte leurs conséquences sur la santé, la qualité de vie et le travail.

Objectif : réduire l'errance médicale et les inégalités professionnelles liées à la santé hormonale.

Faire de la santé reproductive une grande priorité nationale de recherche et reprendre la maîtrise publique des connaissances. .

Créer un programme national dédié, doté de financements supplémentaires, et renforcer les capacités françaises et européennes de recherche sur la reprotoxicité, l'écotoxicité, les pathologies, la douleur et les dispositifs médicaux. Exiger que les études réglementaires nécessaires à la mise sur le marché de substances et produits soient réalisées dans des laboratoires répondant à des exigences européennes de compétence, de transparence et de contrôle, afin de préserver les savoir-faire et la capacité d'expertise publique. Engager un changement de modèle : confier progressivement ces études à des structures indépendantes, notamment publiques, financées par les entreprises qui demandent l'autorisation de mise sur le marché, sans qu'elles choisissent ni ne rémunèrent directement le laboratoire évaluateur.

Objectif : garantir qu'aucun grand champ de la santé reproductive ne reste un angle mort de la recherche et que la puissance publique dispose des connaissances nécessaires pour protéger la santé et l'environnement.

Créer un véritable droit à l'adaptation du travail à la santé reproductive tout au long de la vie.

Ouvrir des possibilités concrètes d'aménagement du travail en cas de menstruations incapacitantes, pathologies gynécologiques, AMP, grossesse, post-partum, périménopause ou ménopause, et renforcer la protection contre les expositions reprotoxiques.

Objectif : permettre de préserver sa santé reproductive sans devoir choisir entre se soigner et travailler.

Former les professionnel·les de santé à la santé reproductive et santé environnementale tout au long de la vie.

Intégrer aux formations initiales et continues des médecins et professionnel·les de première ligne un socle obligatoire sur les pathologies gynécologiques, la fertilité féminine et masculine, le post-partum, l'insuffisance ovarienne prématurée, la périménopause et la ménopause. Y intégrer les violences gynécologiques et obstétricales, le consentement, la relation patient·e-soignant·e, la nutrition, l'activité physique, la santé environnementale et les expositions professionnelles sur la base des connaissances scientifiques.

Objectif :100 % des cursus concernés intègrent ce socle obligatoire.

I AVANT LA **NAISSANCE** ET **ENFANCE**

PROTÉGER LA SANTÉ REPRODUCTIVE DÈS LA VIE FŒTALE ET LES PREMIÈRES ANNÉES

Chiffres clés

L'incidence annuelle estimée de la puberté précoce centrale idiopathique en France métropolitaine était **de 2,68 pour 10 000 filles et 0,24 pour 10 000 garçons sur 2011-2013**, avec de fortes différences géographiques.

Environ **7 000 garçons de moins de 7 ans étaient opérés chaque année pour cryptorchidie** dans les données françaises 2002-2014. La cryptorchidie correspond à l'absence de descente d'un ou des deux testicules dans le scrotum et constitue un indicateur de santé reproductive masculine à surveiller.

Comprendre

Notre santé reproductive ne commence pas avec notre vie sexuelle ni même avec la naissance. Les expositions pendant la grossesse peuvent affecter le développement du fœtus et, pour certaines substances, soulever des enjeux qui se prolongent jusqu'à la santé reproductive future de l'enfant à naître. Chez le fœtus féminin, d'ailleurs, la réserve ovocytaire se constitue avant la naissance.

Le placenta n'est pas une barrière étanche aux pollutions. Une première étude publiée en 2021 a détecté des microplastiques dans 4 des 6 placentas analysés ; en 2024, une autre étude en a identifié dans

les 62 placentas examinés. Ces résultats montrent que l'interface materno-fœtale est elle aussi exposée à la pollution plastique, même si les conséquences sanitaires précises des microplastiques sur la grossesse et le développement restent encore à établir. Protéger la santé reproductive commence donc avant la naissance, en réduisant à la source les expositions évitables. (Sources : Ragusa et al., Environment International, 2021 ; Garcia et al., Toxicological Sciences, 2024.)

Le développement hormonal et reproductif suit un calendrier biologique précis. Une puberté qui survient anormalement tôt n'est donc pas un simple signe d'un développement « plus rapide » : c'est un signal de santé qui doit être repéré et étudié. Les facteurs sont multiples ; les expositions aux perturbateurs endocriniens font partie des facteurs étudiés et les fortes différences géographiques observées justifient une surveillance renforcée.

L'enfance constitue en effet une période de vulnérabilité aux substances capables d'interférer avec le système hormonal. Protéger les enfants suppose donc **d'agir sur leur environnement plutôt que de faire reposer la responsabilité sur les familles.** Un enfant ne choisit ni l'air qu'il respire, ni les substances présentes dans son alimentation, ses jouets ou son école.

C'est aussi dès l'enfance que s'apprennent **la connaissance et le respect de son corps, l'intimité et le consentement.** L'éducation à la vie affective et relationnelle doit permettre à chaque enfant de comprendre progressivement que son corps lui appartient et contribuer à prévenir et repérer les violences sexuelles.

Prévenir, protéger, informer : c'est dès l'enfance que commence une véritable politique de santé reproductive.

Nos propositions

Garantir partout l'application effective de l'EVAR, Éducation à la vie affective et relationnelle. *Assurer réellement les trois séances annuelles, avec des personnels formés, des moyens dédiés, des contenus régulièrement actualisés et un suivi de leur réalisation dans tous les établissements.*

Protéger la santé reproductive dès la grossesse et l'enfance contre les pollutions. *Agir d'abord à la source sur la production, l'usage et la mise sur le marché des perturbateurs endocriniens, PFAS, pesticides et substances CMR/reprotoxiques ; réduire aussi les expositions dans les lieux de vie et de soins -*

maternités, crèches, écoles - et pendant les périodes les plus vulnérables, notamment la vie fœtale et les premières années.

Créer un « Santé-Score » environnemental pour rendre visibles les substances qui menacent notre santé.

Créer un affichage simple, lisible et fondé sur une expertise scientifique indépendante permettant d'identifier, dans les produits du quotidien, la présence de substances préoccupantes pour la santé humaine et l'environnement : perturbateurs endocriniens, substances reprotoxiques, cancérogènes, PFAS et autres substances particulièrement préoccupantes. À l'image du Nutri-Score, l'information doit être immédiatement compréhensible au moment de l'achat et permettre de comparer les produits, avec une attention particulière aux risques pour la santé reproductive et aux périodes de vulnérabilité. Objectif : faire de la santé environnementale un critère visible de nos choix de consommation et inciter les fabricants à substituer les substances les plus préoccupantes.

Mieux repérer les troubles précoces du développement hormonal et reproductif. ***Articuler ce repérage avec la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et les politiques des 1 000 premiers jours : améliorer l'identification des signes de puberté précoce et des autres troubles du développement reproductif, puis garantir une orientation rapide vers une prise en charge adaptée.***

Renforcer la recherche et la surveillance de la santé reproductive dès l'enfance. ***Actualiser régulièrement les données sur la puberté précoce et les autres indicateurs de santé reproductive et mieux étudier leurs liens avec les expositions environnementales.***

Protéger la santé reproductive, c'est commencer avant que les problèmes n'apparaissent.

FOCUS : Santé reproductive, climat et biodiversité

Une politique féministe du vivant : nos corps et ceux des autres espèces partagent un même environnement

CHIFFRES CLÉS

Les **femmes enceintes, nouveau-nés et jeunes enfants** font partie des populations particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs ; l'exposition à la chaleur pendant la grossesse est notamment associée à des risques accrus de prématurité et de faible poids de naissance.

En France, des travaux récents menés sur près de **21 000 grossesses** ont retrouvé une association entre exposition à la chaleur pendant la grossesse et diminution de la croissance fœtale, avec des vulnérabilités sociales et environnementales différenciées.

Certaines substances perturbatrices endocriniennes peuvent affecter **la reproduction et le développement chez l'être humain comme chez les animaux.** La France inscrit d'ailleurs leur action dans une approche « Une seule santé », associant santé humaine, animale et environnementale.

COMPRENDRE

Le changement climatique transforme notre environnement. Nous devons comprendre comment il transforme aussi nos corps. La chaleur extrême constitue déjà un risque documenté pendant la grossesse. Mais nous connaissons encore beaucoup moins ses conséquences sur l'ensemble de la vie reproductive : puberté et développement hormonal, cycles menstruels, qualité spermatique, fertilité, pathologies gynécologiques, insuffisance ovarienne prématurée, périménopause ou ménopause.

Il faut sortir d'une vision de la santé reproductive limitée à la grossesse. Comment des canicules répétées affectent-elles la qualité spermatique ? Peuvent-elles modifier les cycles ou

certains symptômes de la ménopause ? Certaines pathologies gynécologiques rendent-elles plus vulnérable à la chaleur ? Quelles sont les périodes de la vie où les organismes sont les plus sensibles ? **Lorsque les connaissances manquent, notre responsabilité est précisément de les produire.**

Notre santé est aussi liée à celle des autres espèces. Pesticides, perturbateurs endocriniens et autres pollutions chimiques peuvent affecter les systèmes hormonaux, le développement et la reproduction chez l'être humain comme chez les animaux. Pourtant, les données de santé humaine, santé animale et contamination des écosystèmes restent trop souvent étudiées séparément. L'approche « Une seule santé » vise au contraire à considérer ensemble santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Cette approche implique de faire de la santé environnementale un pilier de la santé publique et de l'ensemble des politiques qui façonnent nos expositions : travail, agriculture, éducation, production, logement et aménagement.

Quand la reproduction des espèces est perturbée, c'est aussi un signal sur la santé de notre environnement. Suivre les effets des contaminants et des bouleversements environnementaux sur la reproduction de la faune peut contribuer à détecter des signaux d'alerte et à mieux comprendre les mécanismes auxquels les populations humaines peuvent également être exposées. Il ne s'agit pas d'affirmer que l'effondrement de la biodiversité provoque directement l'infertilité humaine, mais de **comprendre les pressions environnementales communes qui affectent les écosystèmes et notre santé.**

NOS PROPOSITIONS

Faire de la santé reproductive un enjeu de l'adaptation au changement climatique. ***Intégrer les risques reproductifs, maternels et périnataux dans les politiques d'adaptation et les plans de prévention des canicules. Reconnaître notamment la grossesse comme une période de vulnérabilité particulière aux fortes chaleurs, adapter les conditions de travail lorsque cela est nécessaire et garantir la continuité de l'accès à la contraception, à l'IVG, à l'AMP et aux soins gynécologiques et obstétricaux***

lors des événements climatiques extrêmes. ***Objectif : protéger notre santé reproductive et garantir nos droits face à un climat qui change.***

Lancer un programme de recherche «Une seule santé : reproductive» dédié aux bouleversements environnementaux et à la reproduction. *Étudier les effets du changement climatique, des pollutions et de la dégradation des écosystèmes sur la santé reproductive humaine et animale. Chez l'humain, documenter leurs effets sur la puberté, les cycles menstruels, la qualité spermatique, la fertilité, la grossesse, les pathologies gynécologiques, l'insuffisance ovarienne prématurée, la périménopause et la ménopause. Chez les animaux, renforcer la recherche et la surveillance des effets sur la fertilité, le développement sexuel et reproductif et la reproduction des espèces sauvages. Croiser ces données avec celles sur la contamination de l'air, de l'eau, des sols et des écosystèmes.* ***Objectif : détecter plus tôt les risques communs pour la santé humaine, animale et les écosystèmes afin de mieux les prévenir. Notre santé reproductive et celle des autres espèces ne sont pas deux histoires séparées : elles dépendent d'un environnement commun.***

II PUBERTÉ ET ADOLESCENCE

FAIRE DE L'ADOLESCENCE LE PREMIER GRAND RENDEZ-VOUS DE SANTÉ REPRODUCTIVE

Chiffres clés

Plus de 4 adolescentes sur 10 : Dans une étude française menée auprès de 953 adolescentes de 15 à 19 ans, 43,3 % déclarent avoir déjà manqué l'école à cause de douleurs de règles. Près de 93 % rapportent des dysménorrhées.

À 15 ans, **61,6% des filles et 46% des garçons** avaient reçu au moins une dose de vaccin contre les HPV en 2025. La couverture progresse, mais reste éloignée de l'objectif national de 80 % en 2030. L'enjeu est majeur : une couverture élevée permet de prévenir les cancers du col de l'utérus et de réduire d'autres cancers liés aux HPV, notamment certains cancers ORL.

Comprendre

À l'adolescence, apprendre à connaître son corps doit aussi permettre de repérer quand quelque chose ne va pas.

La puberté est un moment décisif de la santé reproductive. Les premières règles, les changements hormonaux et corporels ou l'entrée progressive dans la sexualité soulèvent de nombreuses questions. Pourtant, **la douleur reste trop souvent banalisée,** particulièrement chez les jeunes filles. Manquer régulièrement les cours à cause de ses

règles ne devrait jamais être considéré comme normal.

C'est aussi à cet âge que peuvent apparaître les premiers signes de pathologies comme l'endométriose, le syndrome métabolique et ovarien (SOMP, anciennement SOPK), certains fibromes, des troubles des règles ou des douleurs pelviennes. Repérer plus tôt ces signaux peut permettre d'orienter plus rapidement vers les professionnel·les compétent·es.

Cette politique doit concerner **les filles comme les garçons**. Santé testiculaire, infections sexuellement transmissibles, contraception, fertilité future, consentement ou effets des expositions environnementales : les garçons doivent eux aussi apprendre à connaître leur santé reproductive et à en partager la responsabilité.

Enfin, informer ne signifie pas inquiéter ni assigner les jeunes à un futur projet parental. Il s'agit de leur donner les moyens de **comprendre leur corps, protéger leur santé et exercer librement leurs choix.**

Préserver la fertilité ne signifie pas prescrire la parentalité.

Nos propositions

Faire de l'adolescence le premier grand rendez-vous de santé reproductive. *S'appuyer sur les rendez-vous de prévention existants plutôt que créer une consultation supplémentaire, pour aborder développement pubertaire, règles et douleurs, santé sexuelle, santé reproductive féminine et masculine, fertilité future et facteurs environnementaux.*

Accélérer la vaccination contre les HPV des filles et des garçons. *Renforcer la vaccination au collège et le rattrapage pour atteindre 80 % de couverture en 2030, expliquer son rôle dans la prévention de plusieurs cancers du col de l'utérus et d'autres cancers liés aux HPV, notamment ORL et déployer une information scientifique accessible face aux fausses informations.*

Faire de l'EVARS un véritable outil de connaissance et de prévention en santé reproductive. *Garantir des heures banalisées, un budget dédié et un cadre national harmonisé entre les établissements, avec des contenus et objectifs communs. Organiser des séances mixtes et des temps en groupes séparés lorsque cela favorise la liberté de parole, et mobiliser des intervenant·es formé·es, notamment médecins, sages-femmes, infirmier·ères, psychologues et autres*

professionnel·les compétent·es. Renforcer la connaissance du cycle, des règles, des signes qui doivent conduire à consulter, de la santé reproductive féminine et masculine, du consentement, de la contraception, des IST et des déterminants environnementaux. Mettre à disposition des familles et des élèves un contenu national, ludique et accessible expliquant ce qui est enseigné en EVARS, pourquoi ces séances existent et ce qu'elles apportent à la santé, à la prévention et au consentement.

Prévenir les infections qui affectent la santé sexuelle et reproductive. *Faciliter l'accès au dépistage des IST dès l'adolescence et tout au long de la vie, renforcer l'information sur leurs conséquences possibles sur la santé reproductive et la fertilité, et garantir un accès simple, gratuit et confidentiel à la prévention, au dépistage et aux traitements.*

Garantir une information fiable sur la santé sexuelle et reproductive. *Créer un portail public de référence accessible à toutes et tous, proposant une information claire, scientifiquement validée et régulièrement actualisée sur la puberté, les règles, la contraception, les IST, la fertilité, la grossesse, le post-partum, la ménopause et la santé reproductive masculine. Le faire connaître dès l'adolescence et tout au long de la vie.*

Ne plus banaliser les règles douloureuses au collège et au lycée. *Mieux informer les élèves et les personnels, permettre une orientation vers le soin lorsque les douleurs sont importantes ou répétées et éviter que ces symptômes conduisent au décrochage ou à l'absentéisme.*

Faire entrer pleinement les garçons dans la politique de santé reproductive. *Développer dès l'adolescence la prévention concernant santé testiculaire, fertilité, contraception masculine, IST, santé sexuelle et effets des expositions environnementales et professionnelles futures.*

III LA VIE D'ADULTE

DIAGNOSTIQUER PLUS TÔT, MIEUX SOIGNER, GARANTIR LE LIBRE CHOIX

Chiffres clés

Environ **10 % des femmes en âge de procréer sont atteintes d'endométriose en France**. Le SOMP (anciennement SOPK), qui concernerait 10 à 13 % des femmes en âge de procréer dans le monde, doit bénéficier d'une visibilité comparable, notamment en raison de ses conséquences métaboliques, cardiovasculaires, psychologiques et reproductives.

Les fibromes utérins sont très fréquents au cours de la vie, avec d'importantes inégalités selon les populations : les données publiées rapportent une fréquence d'environ **70 % chez les femmes blanches et supérieure à 80 % chez les femmes noires.** Cette pathologie doit être mieux reconnue, documentée et prise en charge.

L'insuffisance ovarienne prématurée concerne **environ 1 % des femmes avant 40 ans.** Elle ne pose pas seulement une question de fertilité : ses conséquences osseuses, cardiovasculaires, sexuelles et psychologiques peuvent accompagner la femme tout au long de sa vie.

Comprendre

La santé reproductive ne se résume ni à avoir des enfants, ni à ne pas en avoir. Elle concerne notre santé tout au long de la vie.

À l'âge adulte, des millions de femmes vivent avec des douleurs, des

saignements importants, des troubles du cycle ou des dérèglements hormonaux. Endométriose, SOMP (anciennement SOPK), adénomyose, fibromes ou insuffisance ovarienne prématurée peuvent affecter la santé physique et mentale, la sexualité, le travail et la qualité de vie. Pourtant, les symptômes restent encore trop souvent banalisés et les diagnostics tardifs.

La mobilisation autour de l'endométriose a permis de faire progresser la reconnaissance de la maladie. Une stratégie nationale existe depuis 2022 et des filières régionales ont été constituées. Le plan fertilité lancé en 2026 prévoit également des actions concernant l'endométriose et le SOMP (anciennement SOPK). Notre objectif n'est donc pas de recréer ce qui existe, mais d'étendre cette dynamique aux pathologies encore insuffisamment structurées et de mesurer réellement les délais de diagnostic.

La santé reproductive adulte concerne aussi les hommes : santé testiculaire, troubles hormonaux et sexuels, contraception, fertilité et expositions professionnelles ou environnementales restent insuffisamment présents dans la prévention. **Mieux prendre soin de la santé reproductive des hommes, c'est aussi mieux partager la responsabilité reproductive.**

Enfin, une politique de santé reproductive doit garantir des choix. Pouvoir choisir sa contraception, interrompre une grossesse ou décider de ne pas avoir d'enfant relève de la même exigence : **permettre à chacune et chacun de disposer librement de son corps.**

Nos propositions

Étendre à l'ensemble de la santé reproductive la dynamique engagée contre l'endométriose. *Structurer des parcours pour le SOMP, l'adénomyose, les fibromes, l'insuffisance ovarienne prématurée et les pathologies reproductives masculines. Former les professionnel·les de première ligne pour que, dès la première consultation, les symptômes évocateurs conduisent à une orientation et à un diagnostic sans délai évitable.*

Garantir partout l'accès effectif à l'IVG et le libre choix de la méthode. *Garantir dans chaque territoire une offre suffisante d'IVG médicamenteuse et instrumentale, publier les délais et distances d'accès et assurer une orientation rapide lorsqu'un établissement ne peut répondre à la demande, notamment dans les territoires ruraux et ultramarins.* ***Un droit inscrit dans***

la Constitution doit être un droit accessible partout.

Accélérer la recherche publique sur la contraception masculine. *Soutenir le développement et l'évaluation de méthodes contraceptives masculines afin de* ***diversifier les choix et mieux partager la responsabilité contraceptive.***

Faire de la santé reproductive masculine un véritable sujet de prévention. *Intégrer davantage la santé testiculaire, les troubles hormonaux et sexuels, la fertilité et les conséquences des expositions environnementales et professionnelles. Développer l'offre d'andrologie et d'urologie reproductive sur le territoire afin que la prévention débouche réellement sur un accès aux soins.*

Rendre effectif le droit à l'adaptation du travail à la santé reproductive tout au long de la vie. *Menstruations incapacitantes, pathologies gynécologiques, AMP, grossesse, post-partum, périménopause et ménopause doivent ouvrir des possibilités concrètes d'aménagement. Augmenter les moyens de la médecine du travail et les effectifs mobilisés, renforcer les contrôles des expositions reprotoxiques et, avec l'accord des salarié·es, mettre en place un suivi spécifique lorsque la situation le justifie, notamment en périnatalité, afin de vérifier l'adaptation effective du poste et la connaissance des droits.*

FOCUS : La Santé reproductive masculine

Faire enfin entrer les hommes dans la santé reproductive

En ce qui concerne l'accès au soin, l'offre d'andrologie et d'urologie reproductive reste inégalement répartie : la prévention n'a de sens que si une orientation vers un professionnel formé est réellement possible dans chaque territoire.

CHIFFRES CLÉS

La concentration moyenne de spermatozoïdes observée dans une grande méta-analyse internationale est passée de **101 millions/ml en 1973 à 49 millions/ml en 2018,** soit une diminution de plus de moitié. Ce résultat constitue un signal important, mais **ne signifie pas que la fertilité masculine aurait diminué de 50 %.**

Les anomalies de la production des spermatozoïdes figurent parmi les principales causes identifiées d'infertilité masculine.

En matière de contraception, les options masculines validées et disponibles restent très limitées : **préservatif et vasectomie** constituent les principales méthodes efficaces ; la recherche sur de nouvelles méthodes n'a toujours pas abouti à une offre comparable à celle proposée aux femmes.

COMPRENDRE

La santé reproductive n'est pas une affaire de femmes. De la puberté au vieillissement, les hommes sont eux aussi concernés par la santé hormonale et testiculaire, la sexualité, la contraception, la fertilité, le désir d'avoir des enfants, les cancers et les effets des expositions environnementales ou professionnelles.

Pourtant, les hommes entrent encore trop souvent dans le système de santé reproductive au moment où survient une difficulté à concevoir. Même lorsque les recommandations prévoient une évaluation uro-andrologique, l'accès réel est

freiné par le manque de professionnel·les et leur répartition géographique. La charge médicale, mentale et sociale reste alors largement associée aux femmes.

Cette invisibilisation a aussi une conséquence très concrète : la contraception repose encore très majoritairement sur les femmes. La stratégie nationale de santé sexuelle reconnaît déjà cet enjeu et le Gouvernement a engagé des travaux sur les méthodes masculines ; notre plus-value doit donc être d'accélérer la recherche publique et de faire du partage de la charge contraceptive un objectif explicite de politique publique.

Enfin, la santé reproductive masculine est aussi une question de santé environnementale. Les effets possibles de certaines expositions sur la qualité spermatique et la fertilité font l'objet de travaux scientifiques, et le Gouvernement reconnaît désormais explicitement l'impact des facteurs environnementaux dans sa politique de fertilité.

NOS PROPOSITIONS

Faire de la santé reproductive masculine un véritable sujet de prévention. *Intégrer dès l'adolescence la santé testiculaire et hormonale, la fertilité, la sexualité, la contraception et les facteurs de risque dans l'information et la prévention en santé. Former les professionnel·les à mieux repérer et orienter les troubles de santé reproductive masculine. Objectif : ne plus attendre un parcours d'infertilité ou une pathologie pour parler aux hommes de leur santé reproductive.*

Garantir l'application effective des recommandations de parcours pour les deux partenaires. *Lorsqu'il y a deux partenaires, organiser dès l'entrée dans le parcours l'évaluation de chacun·e selon les recommandations de la HAS, avec un accès effectif à l'andrologie et à l'urologie reproductive lorsque nécessaire, en corrigeant les déserts de soins spécialisés.* ***Objectif : sortir d'un parcours encore trop souvent centré médicalement et mentalement sur les femmes.***

Faire de la contraception masculine une priorité de recherche publique. *Soutenir durablement la recherche clinique et fondamentale sur des contraceptions masculines efficaces, réversibles et sûres, afin d'élargir réellement les choix contraceptifs et de mieux partager la charge de la contraception. Les méthodes hormonales et non hormonales font déjà l'objet de recherches, mais aucune nouvelle solution n'a encore rejoint l'offre courante.* ***Objectif : permettre demain aux femmes et aux hommes de partager réellement la responsabilité contraceptive.***

Mieux protéger la santé reproductive masculine des expositions environnementales et professionnelles. Intégrer pleinement fertilité et santé hormonale masculine dans la prévention des expositions reprotoxiques et aux perturbateurs endocriniens, notamment au travail, renforcer la recherche et intégrer rapidement aux politiques publiques les nouvelles recommandations professionnelles à mesure de leur publication. ***Objectif : faire de la santé reproductive masculine un indicateur à part entière de notre politique de santé environnementale. Mieux prendre soin de la santé reproductive des hommes, c'est aussi mieux partager la responsabilité reproductive.***

IV DÉSIR D'ENFANT ET FERTILITÉ

NE PLUS FAIRE DE L'AMP* UN PARCOURS DU COMBATTANT : PERMETTRE À CHACUN·E D'ÊTRE ACTEUR·RICE MÉDICAL·E DE SON PROJET DE PROCRÉATION

*Assistance Médicale à la Procréation

Chiffres clés

L'infertilité concerne une part importante de la population en âge de procréer. En France, le rapport de 2022 estimait à plus de **3 millions le nombre de personnes concernées** ; cette estimation ne comptabilise pas nécessairement les deux membres d'un couple. Lorsqu'aucune cause n'est identifiée, parler d'infertilité « inexpliquée en l'état actuel de la science et des outils disponibles » rappelle aussi le besoin de recherche et de diagnostics plus personnalisés.

Près d'1 enfant sur 24 naît après une AMP réalisée et enregistrée en France ; en 2023, 28 440 enfants sont nés après une AMP. Ce chiffre ne comptabilise pas les enfants conçus à l'issue de parcours d'AMP réalisés à l'étranger.

– 52 % de concentration spermatique moyenne entre 1973 et 2018 dans une vaste méta-analyse internationale. Cette évolution constitue un signal important pour la santé reproductive masculine, sans être à elle seule une mesure de l'infertilité.

Comprendre

Désirer un enfant et ne pas réussir à l'avoir, c'est parfois voir les mois puis les années passées au rythme des essais, des examens, des traitements et des espoirs déçus. Pour certaines personnes s'ajoutent les arrêts spontanés de grossesse ou les tentatives d'AMP qui n'aboutissent pas. Cette succession d'espoirs et d'échecs peut être extrêmement éprouvante. Elle peut bouleverser le rapport au corps, à la sexualité, au couple, au travail, à la santé mentale et jusqu'à la manière de se projeter dans l'avenir.

L'AMP ouvre des possibilités, mais elle ne doit plus être un parcours du combattant. L'organisation de l'offre de soins peut aujourd'hui ajouter des difficultés aux traitements : délais, déplacements, pratiques hétérogènes entre centres, examens répétés, ponctions, transferts, attente et incertitude. Nous voulons permettre aux personnes de devenir pleinement actrices médicales de leur projet de procréation : comprendre les options, participer aux décisions et disposer d'un parcours coordonné. Lorsqu'il y a deux partenaires, il doit y avoir deux patient·es ; la charge médicale ne peut continuer à reposer principalement sur le corps des femmes.

À cette épreuve intime s'ajoutent des inégalités d'accès liées au territoire, aux ressources financières et à l'organisation de l'offre. Dans les territoires ruraux et ultramarins, les distances, déplacements et séjours peuvent rendre les parcours particulièrement lourds et réduire les chances d'aboutissement du projet parental. Les discriminations n'ont pas non plus disparu avec l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Accompagner tous les parcours, c'est garantir que le lieu de vie, les revenus, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou la situation familiale ne déterminent pas l'accès aux soins ni les chances de mener son projet parental.

Enfin, notre cadre bioéthique doit pouvoir évoluer avec la société et les besoins des personnes. Le DPI-A pose une question d'accès à une information génétique utile dans certaines situations médicales ; la ROPA relève d'abord d'une exigence d'égalité pour permettre, au sein d'un couple de femmes, que l'une fournisse ses ovocytes et que l'autre porte la grossesse. Ces évolutions doivent s'inscrire dans un cadre médical et éthique exigeant, sans promettre l'impossible ni transformer le désir d'enfant en injonction.

Derrière un parcours d'infertilité, il y a bien plus qu'un dossier médical :

il y a des corps éprouvés, des espoirs, des échecs, parfois des deuils et des projets de vie bouleversés. Accompagner tous les parcours, c'est ne laisser personne traverser cela seul·e et rendre les parcours plus cohérents, plus rapides et plus efficaces.

Nos propositions

Améliorer la qualité et l'efficience de tous les parcours d'infertilité et d'AMP. *Organiser un parcours coordonné, qu'il soit individuel ou en couple ; lorsqu'il y a deux partenaires, évaluer chacun·e dès le début selon les recommandations médicales. Harmoniser les pratiques entre centres, améliorer l'accès aux examens pertinents, à l'andrologie et à l'accompagnement psychologique, et mesurer les délais comme les résultats des parcours.*

Développer les capacités d'autoconservation ovocytaire non médicale dans les centres d'AMP publics et privés non lucratifs, avec des objectifs régionaux permettant de réduire les délais et les inégalités territoriales. *Garantir une information claire sur les chances de réussite, les risques et les limites de la technique, ainsi que des exigences renforcées de qualité, de sécurité et de traçabilité.*

Garantir des parcours d'AMP sans discrimination ni freins organisationnels. *Garantir un accueil et une prise en charge sans discrimination liée notamment à l'orientation sexuelle, à un handicap, à la situation familiale ou à l'identité de genre, former les professionnel·les, permettre un signalement effectif et identifier les critères ou pratiques organisationnelles qui créent des inégalités d'accès. Faire évoluer le droit afin de permettre aux personnes trans d'accéder à l'AMP indépendamment de leur marqueur de genre à l'état civil lorsqu'elles disposent des capacités physiologiques nécessaires.*

Garantir l'égalité territoriale devant l'AMP. *Fixer des objectifs de réduction des délais, publier les délais d'accès par centre et organiser une réponse spécifique pour les territoires ruraux et ultramarins afin que le lieu de résidence ne détermine plus les chances de mener son projet parental.*

Faire de la qualité de vie une composante à part entière des parcours d'infertilité et d'AMP. *Garantir une information compréhensible, un accompagnement psychologique accessible lorsque les personnes le souhaitent et mieux prendre en compte les conséquences de l'infertilité et des traitements sur la santé mentale, la sexualité, le couple, le travail et la vie sociale. Associer davantage les patient·es et leurs associations à l'évaluation et à l'amélioration des parcours.*

Réduire les restes à charge dans les parcours d'AMP. *Garantir une prise en charge financière effective des traitements et médicaments médicalement nécessaires au parcours, y compris lorsque certaines prescriptions utiles restent aujourd'hui hors nomenclature, afin que les ressources financières ne deviennent pas un facteur de renoncement ou d'inégalité.*

Réduire les délais d'accès au don de gamètes. *Renforcer les capacités des centres confrontés aux listes d'attente, examiner l'ouverture de l'activité de don à davantage de centres publics et privés agréés lorsque les exigences de qualité et de sécurité sont réunies, améliorer l'information sur le don et harmoniser les critères et l'accompagnement des donneur·ses, des personnes receveuses et des enfants issus d'un don.*

Autoriser le DPI-A dans des indications médicales ciblées. *Permettre l'analyse de l'euploïdie afin d'apporter une information sur le potentiel implantatoire des embryons dans certaines situations médicales précisément définies. Organiser en France le suivi de son impact sur les taux de grossesse, la durée des parcours et l'expérience des patient·es.*

Autoriser la ROPA pour les couples concernés. *Permettre, dans le cadre de l'AMP, qu'une personne fournisse ses ovocytes et que sa partenaire porte la grossesse. Cette mesure répond à une exigence d'égalité entre projets parentaux, dans un cadre garantissant le consentement, la sécurité médicale et l'accompagnement des personnes.*

Ouvrir l'AMP post-mortem dans un cadre strict. *Permettre, après le décès d'un conjoint ou d'une conjointe, la poursuite d'un projet parental lorsque la personne décédée a exprimé un consentement préalable, libre, explicite et spécifique, avec un délai de réflexion et un accompagnement médical, psychologique et juridique de la personne survivante.*

FOCUS : Cancer et santé reproductive

Prévenir les expositions, protéger la décision publique, prendre soin de l'après

CHIFFRES CLÉS

Le **cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes**. Son incidence standardisée est passée de **72,8 à 99,2 cas pour 100 000 femmes entre 1990 et 2023,** soit une hausse d'environ 36 %.

L'exposition professionnelle aux **pesticides est reconnue comme facteur de risque du cancer de la prostate** en France depuis 2021. Les cancers de la prostate provoqués par les pesticides peuvent être reconnus comme maladies professionnelles.

Pour **le cancer de l'ovaire,** les données concernant certaines expositions, notamment aux pesticides, restent insuffisantes : tous les cancers et toutes les expositions ne présentent donc pas le même niveau de preuve.

En 2024, **la santé, l'agriculture et l'agroalimentaire et l'environnement comptaient parmi les principaux secteurs d'activité du lobbying déclaré en France.** Plus de la moitié des actions déclarées concernaient le contenu d'un projet ou d'une proposition de loi.

COMPRENDRE

Les cancers qui touchent notre santé reproductive ne commencent pas au moment du diagnostic. Cancer du sein, de la prostate, de l'ovaire ou du testicule : leurs causes sont multiples. Mais pour certains cancers, la recherche établit ou suspecte également le rôle d'expositions environnementales ou professionnelles. Le chlordécone en constitue un exemple majeur : le lien avec le risque de cancer de la prostate présente

une présomption forte et une causalité jugée vraisemblable.

Prévenir ne peut donc pas signifier seulement demander aux individus de changer leurs comportements ou de se faire dépister. Nous devons aussi agir sur les expositions qu'ils et elles ne choisissent pas : au travail, dans leur environnement ou à travers certains produits du quotidien. Lorsque les connaissances restent insuffisantes, comme pour certaines expositions et le cancer de l'ovaire, nous devons renforcer la recherche plutôt que transformer une suspicion en certitude.

Encore faut-il que les connaissances scientifiques conduisent à des décisions. Les intérêts économiques organisés participent légitimement au débat public, mais leur influence doit être transparente et ne doit jamais primer sur la protection de la santé. Un rapport parlementaire de 2026 souligne encore que certaines stratégies d'influence économique peuvent entretenir l'incertitude scientifique et retarder des décisions réglementaires : la « fabrique du doute » n'appartient pas qu'au passé. L'indépendance de l'expertise est déjà protégée par des règles, notamment à l'Anses ; notre enjeu est de la consolider et surtout de garantir que l'action publique suive lorsque les connaissances justifient d'agir.

Enfin, **guérir d'un cancer ne signifie pas toujours retrouver le corps et la vie d'avant.** Les traitements peuvent affecter la fertilité, mais aussi la santé hormonale, la fonction ovarienne ou testiculaire, la sexualité, provoquer une ménopause induite, des douleurs ou bouleverser l'image du corps et la santé psychique. Notre politique de santé reproductive doit donc penser aussi la vie après le cancer.

NOS PROPOSITIONS

Faire de la santé environnementale un des piliers de la santé et des politiques publiques en France. ***Faire primer la santé sur les intérêts économiques dans la prévention des cancers. Réduire à la source les expositions environnementales et professionnelles susceptibles de contribuer aux cancers du sein, de la prostate, de l'ovaire ou du testicule, selon le niveau de preuve scientifique. Renforcer la protection des***

personnes exposées au travail et la recherche sur les risques encore insuffisamment documentés. Garantir l'indépendance de l'expertise publique et renforcer la transparence sur les activités de lobbying concernant les substances cancérogènes, reprotoxiques et perturbatrices endocriniennes afin que les intérêts économiques ne puissent pas retarder les décisions nécessaires à la protection de la santé. Faire de la santé environnementale un pilier transversal des politiques publiques de santé, de travail, d'agriculture, d'éducation et de production. ***Objectif : faire de la réduction des expositions évitables un pilier de la prévention et protéger la décision publique des conflits d'intérêts et des stratégies de fabrique du doute.***

Garantir le droit à une santé reproductive et sexuelle après un cancer. *Intégrer pleinement au suivi après cancer, selon la maladie, les traitements et les besoins de chaque personne, leurs conséquences sur la santé hormonale, la fonction ovarienne ou testiculaire, la ménopause induite, la sexualité, les douleurs, l'image du corps et la santé psychique, avec une orientation coordonnée vers les professionnel·les compétent·es.* ***Objectif : ne plus considérer la guérison du cancer comme la fin de la prise en charge de ses conséquences sur la santé reproductive. Prévenir les cancers, c'est aussi agir sur les expositions que nous ne choisissons pas. Et lorsque la santé se heurte à des intérêts économiques, la protection de la santé doit primer.***

V GROSSESSE, MATERNITÉ ET POST-PARTUM

DISTINGUER LES PATHOLOGIES PRÉCOCES DES ÉTAPES DE LA VIE, MIEUX INFORMER ET MIEUX SOIGNER

Chiffres clés

Seulement **24,9 % des femmes ont bénéficié en 2024 de l'entretien postnatal précoce**, pourtant obligatoire depuis 2022.

79,1 % des mères avaient bénéficié en 2021 d'une visite à domicile par une sage-femme après l'accouchement : le suivi existe donc, mais il reste principalement médical et concentré dans les premiers jours.

La mortalité infantile augmente en moyenne **d'environ 1 % par an depuis 2014,** principalement sous l'effet de la mortalité néonatale.

Comprendre

Investir dans la grossesse, la naissance et les premières années de vie, c'est agir à un moment déterminant pour la santé future. C'est prévenir plutôt que réparer. Investir dans la prévention est aussi un choix d'efficacité collective : prévenir les complications et les pathologies évitables coûte moins humainement, socialement et financièrement que les réparer tardivement.

Mettre un enfant au monde ne devrait jamais signifier devoir choisir entre sa santé, son travail, ses revenus et la possibilité de souffler.

La grossesse et l'accouchement sont des bouleversements physiques, hormonaux et psychiques majeurs. Pourtant, toutes les

personnes enceintes ne sont pas égales face aux risques. Territoire, précarité, handicap, conditions de travail ou exposition aux pollutions peuvent déterminer l'accès aux soins et peser sur la santé de la mère et de l'enfant. Alors que nos indicateurs périnataux se dégradent, **la sécurité d'une naissance ne peut dépendre du code postal.**

La sécurité ne se mesure pas seulement à l'intérieur de la maternité : elle commence par la possibilité d'y arriver à temps.

Accoucher ne signifie jamais renoncer à décider de son corps. Le consentement est déjà un droit ; il faut désormais le rendre effectif à chaque geste et reconnaître pleinement les violences gynécologiques et obstétricales. Les Écologistes ont déjà porté cette bataille au Parlement.

Mais **l'un des grands angles morts commence précisément lorsque les portes de la maternité se referment.** Le suivi à domicile par une sage-femme existe, notamment jusqu'au douzième jour, et un entretien postnatal est obligatoire. Pourtant, le retour à la maison signifie aussi nuits fragmentées, douleurs, cicatrices, récupération physique, alimentation du bébé, tâches ménagères, démarches administratives, isolement et parfois détresse psychique. **Une consultation ne fait pas les courses, ne prépare pas un repas et ne permet pas de dormir quelques heures.**

Nos propositions

GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT

Faciliter concrètement la vie quotidienne pendant la grossesse. *Mettre à disposition, sur la base du volontariat, un badge national de priorité grossesse permettant de signaler sans avoir à se justifier le besoin d'une place assise ou d'un passage prioritaire dans les transports et files d'attente.*

Garantir partout des maternités sûres, accessibles et suffisamment dotées. *Objectif :* ***Atteindre 100 % des maternités respectant les ratios d'effectifs et de sécurité définis par la HAS, renforcer prioritairement les équipes en tension et garantir*** *transport et hébergement lorsque l'éloignement d'une maternité adaptée est incontournable.*

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé maternelle et périnatale. *Publier chaque année les principaux indicateurs par territoire et niveau de vulnérabilité sociale et concentrer les moyens supplémentaires là où les risques sont*

les plus élevés, notamment en Outre-mer, dans les territoires ruraux et auprès des personnes en situation de précarité ou de handicap. ***La sécurité d'une grossesse ne doit dépendre ni de son adresse ni de ses revenus.***

Garantir un véritable choix des conditions et du lieu de naissance. *Développer les maisons de naissance sur tout le territoire et sécuriser l'accouchement à domicile accompagné lorsqu'il est médicalement possible, avec des protocoles territoriaux entre sages-femmes, maternités et SAMU garantissant des transferts rapides. Faire du projet de naissance un élément reconnu du parcours de soins et garantir, sauf nécessité médicale, le choix de la position d'accouchement plutôt que des pratiques dictées par la seule commodité du geste obstétrical.*

Prévenir les violences gynécologiques et obstétricales et restaurer la confiance dans le soin. *Former systématiquement les équipes au consentement, à l'écoute, à l'information et à l'accueil de la parole des patientes ; faciliter le signalement et le recours lorsque les droits ne sont pas respectés. Réconcilier patientes et soignant·es suppose que chacune soit comprise, respectée et pleinement associée aux décisions qui concernent son corps.*

Protéger la grossesse contre les risques environnementaux, professionnels et climatiques. *Décliner notre mesure phare environnementale pendant la grossesse : repérer les expositions reprotoxiques, protéger immédiatement au travail lorsqu'une exposition ne peut être supprimée et intégrer systématiquement les personnes enceintes aux politiques d'adaptation aux fortes chaleurs.*

APRÈS LA NAISSANCE : DES SOINS, DU TEMPS ET DES BRAS

Faire du post-partum une période de soins à part entière. *Garantir pendant la première année après l'accouchement un véritable parcours de santé physique, gynécologique, sexuelle et psychique, avec repérage systématique de la dépression du post-partum, prise en charge des séquelles de l'accouchement et accès rapide aux soins nécessaires.* ***Objectif d'effectivité :*** *porter* ***de 24,9 % à au moins 80 % en cinq ans*** *la réalisation de l'entretien postnatal précoce et garantir une orientation effective lorsqu'une difficulté est repérée.*

Créer un véritable service public de l'accompagnement à domicile après la naissance. *Garantir à toutes les familles qui en expriment le besoin un nombre d'heures d'aide à domicile prises en charge après la naissance, renforcé automatiquement en cas de naissance multiple, monoparentalité, handicap, précarité, isolement ou suites de couches difficiles. Mobiliser sages-femmes, PMI, TISF et professionnel·les de l'aide à domicile pour apporter des soins mais aussi une aide concrète au quotidien.*

Faire du congé après la naissance un véritable outil d'égalité entre les parents. *Aller au-delà du nouveau congé supplémentaire de naissance de 2026 pour construire un congé parental mieux rémunéré, suffisamment long et comportant une part individuelle non transférable pour chaque parent, afin que son utilisation ne repose plus principalement sur les femmes et que les familles modestes puissent réellement se permettre de le prendre. Aujourd'hui, pour une naissance simple, le congé maternité de droit commun est de 16 semaines et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires, auxquels s'ajoutent 3 jours de congé de naissance : ces écarts continuent de structurer très tôt une répartition inégale du soin au nouveau-né.* ***Une politique familiale ne peut pas s'arrêter à la porte de la maternité. Après la naissance, personne ne devrait être laissé seul face aux soins, à l'épuisement et à la charge du quotidien.***

ARRÊTS SPONTANÉS DE GROSSESSE, PERTES DE GROSSESSE ET DEUIL PÉRINATAL

Garantir partout un véritable parcours après un arrêt spontané de grossesse, une perte de grossesse ou un deuil périnatal. *Rendre effectif dans chaque territoire un parcours médical et psychologique continu, avec une information systématique sur les droits, les ressources disponibles et les possibilités d'accompagnement pour la personne concernée comme pour son ou sa partenaire. Renforcer l'accès à des psychologues formé·es au deuil périnatal et garantir une orientation rapide lorsque la souffrance le nécessite.*

Créer une plateforme nationale d'information sur les arrêts spontanés de grossesse et le deuil périnatal. *Réunir dans un même espace public des informations médicales fiables, les signes nécessitant de consulter en urgence, les droits sociaux et professionnels, les possibilités d'accompagnement*

psychologique, les associations et les ressources territoriales.

Mieux préparer et informer sans banaliser la perte. *Intégrer dans les enseignements de SVT, avec des contenus adaptés à l'âge, une information simple sur la reproduction humaine : une grossesse n'aboutit pas systématiquement à une naissance et des arrêts spontanés peuvent survenir naturellement. L'objectif est de transmettre des connaissances scientifiques, de réduire la culpabilité et de faire connaître les ressources d'aide.*

Le besoin d'accompagnement ne se mesure pas au nombre de semaines de grossesse.

SANTÉ DU NOUVEAU-NÉ

Réduire d'au moins 30 % la mortalité infantile en cinq ans. *Faire de la remontée de la France parmi les pays européens les plus performants un objectif national de santé publique, publier annuellement les résultats et renforcer prioritairement les actions dans les territoires et populations où les risques sont les plus élevés. La France est aujourd'hui au 21e rang européen sur 27 avec 4,08 décès pour 1 000 naissances vivantes.*

VI INSUFFISANCE OVARIENNE PRÉMATURÉE, PÉRIMÉNOPAUSE, MÉNOPAUSE ET ANDROPAUSE

DISTINGUER LES PATHOLOGIES PRÉCOCES DES ÉTAPES DE LA VIE, MIEUX INFORMER ET MIEUX SOIGNER

Comprendre

La fin de la fertilité n'est pas la fin de la santé reproductive.

La périménopause peut commencer plusieurs années avant les dernières règles. Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, troubles du sommeil, fatigue, douleurs, difficultés de concentration, troubles de l'humeur, sécheresse vaginale, troubles urinaires ou sexuels : pour certaines femmes, ces bouleversements hormonaux peuvent affecter profondément **le corps, la santé mentale, la sexualité, le travail et la manière de se reconnaître soi-même.**

L'insuffisance ovarienne prématurée doit être distinguée de la ménopause liée à l'âge. Survenant avant 40 ans, parfois chez de très jeunes femmes, elle constitue une pathologie spécifique dont les conséquences dépassent largement la fertilité : santé hormonale, osseuse et cardiovasculaire, sexualité, santé psychique et qualité de vie peuvent être affectées durablement. Elle justifie un parcours dédié et une visibilité propre.

La ménopause, elle, n'est ni une maladie qu'il faudrait systématiquement traiter, ni une fatalité dont il faudrait supporter les symptômes en silence. **Chaque femme doit pouvoir comprendre ce qui arrive à son corps, connaître les bénéfices et les risques des différents traitements et décider librement de la prise en charge qui lui convient.**Cela suppose aussi des professionnel·les réellement formé·es.

Enfin, cette période doit être considérée comme un enjeu de **santé globale.** Santé cardiovasculaire et osseuse, activité physique,

alimentation, sommeil, santé mentale, sexualité et prévention doivent pouvoir être abordés ensemble. Cela suppose de sortir d'une médecine qui intervient seulement lorsque la maladie apparaît pour développer une véritable politique de prévention, fondée sur les connaissances scientifiques et adaptée à chaque personne.

Nos propositions

Faire de la périménopause et de la ménopause un véritable enjeu de santé publique. *Garantir, dès les premiers symptômes, un parcours identifiable et accessible intégrant santé hormonale, gynécologique et sexuelle, santé mentale, cardiovasculaire et osseuse, avec accès aux traitements adaptés et orientation spécialisée pour les situations complexes.*

Garantir un véritable parcours de soins et d'accompagnement pour l'insuffisance ovarienne prématurée avant 40 ans. *Organiser dès le diagnostic une prise en charge coordonnée, notamment en hôpital de jour, associant* ***suivi physique, hormonal et psychologique,*** *santé sexuelle et prévention des risques à long terme. Garantir un réel accompagnement psychologique dès l'annonce et dans la durée, face aux bouleversements du corps, de l'image de soi et des projets de vie.* ***Ne pas réduire la santé des jeunes femmes à leur fertilité.***

Former les professionnel·les de santé à la santé reproductive tout au long de la vie. *Garantir dans les formations initiales et continues des médecins et professionnel·les de première ligne un socle obligatoire sur les principales pathologies gynécologiques, la fertilité féminine et masculine, le post-partum, l'IOP, la périménopause et la ménopause. Y intégrer une véritable formation à la nutrition, l'activité physique, la santé environnementale et aux expositions professionnelles, fondée sur les données scientifiques.* ***Objectif :*** *100 % des cursus concernés intègrent ce socle obligatoire. S'appuyer sur les recommandations actualisées de la HAS sur fertilité, santé globale et exploration de l'infertilité en première intention pour harmoniser les pratiques et éviter les pertes de chance.*

Garantir à toutes un accès effectif aux traitements de la ménopause. *Garantir une information claire et indépendante sur les bénéfices, les risques et les alternatives des traitements hormonaux et non hormonaux et lever les obstacles médicaux, territoriaux et financiers à leur accès.* ***L'objectif n'est pas de prescrire davantage, mais de permettre à chacune de choisir***

une prise en charge adaptée et éclairée.

Faire de la périménopause et de la ménopause un moment de prévention en santé globale. *Intégrer au parcours, selon les besoins et facteurs de risque, la prévention cardiovasculaire, osseuse et métabolique, avec une attention renforcée à la santé mentale ainsi qu'à l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et la santé sexuelle. Renforcer l'information publique pour permettre de distinguer les recommandations fondées sur les connaissances scientifiques des régimes, compléments et produits « anti-ménopause » sans bénéfice démontré.*

Créer un véritable droit à l'adaptation du travail à la santé reproductive tout au long de la vie. *Menstruations incapacitantes, pathologies gynécologiques, AMP, grossesse, post-partum, périménopause et ménopause doivent ouvrir des possibilités concrètes d'aménagement, tout en renforçant la protection contre les expositions reprotoxiques.*

Pour la ménopause, nous pouvons nous inspirer de l'expérience britannique pour rendre obligatoires dans les grandes entreprises et administrations **des plans d'action de santé reproductive au travail :** formation des managers, horaires et pauses adaptés, télétravail lorsque possible, adaptation de la température et de la ventilation, espaces de repos et mobilisation de la médecine du travail. **Notre différence : ne pas réserver ces adaptations à la ménopause, mais les étendre à l'ensemble de la santé reproductive.**

FOCUS : Inégalités raciales, sociales, et territoriales de santé reproductive

Notre santé reproductive ne doit dépendre ni de notre origine, ni de notre adresse, ni de nos revenus

CHIFFRES CLÉS

En 2016-2018, les femmes résidant dans les DROM présentaient un risque de mortalité maternelle environ deux fois supérieur à celui des femmes de métropole.

Sur la même période, le risque de mortalité maternelle des femmes nées en Afrique subsaharienne était 3,1 fois celui des femmes nées en France.

18 naissances sur 1000 contre 11 naissances sur 1000 — La mortalité périnatale reste nettement plus élevée dans les DROM qu'en métropole dans les données reprises dans ce livret.

Les données épidémiologiques montrent une fréquence et une sévérité plus importantes des fibromes chez les femmes noires : un angle mort qui doit être mieux documenté en France.

COMPRENDRE

Nous ne sommes pas toutes et tous égaux face à la santé reproductive. Le territoire où l'on vit, les revenus, l'origine réelle ou supposée, les discriminations subies, les conditions de travail et l'éloignement des soins peuvent se cumuler et modifier l'exposition aux risques, le délai avant un diagnostic et l'accès à une prise en charge de qualité.

Les inégalités territoriales sont particulièrement visibles dans les territoires dits d'Outre-mer et les territoires ruraux. Les écarts de mortalité maternelle et périnatale, les fermetures ou l'éloignement des maternités, le manque de spécialistes et les distances vers les centres d'AMP peuvent transformer un droit

national en droit théorique. La sécurité d'une grossesse ou les chances de mener un projet parental ne doivent pas dépendre d'un code postal.

Les inégalités sont aussi raciales et liées aux parcours migratoires. Santé publique France documente une surmortalité maternelle persistante des femmes nées en Afrique subsaharienne et des travaux sur les parcours de soins montrent que l'accès à des soins de qualité participe aux inégalités observées. Ces écarts ne doivent jamais être naturalisés : ils imposent d'étudier les discriminations, les biais de prise en charge, les barrières linguistiques et sociales et l'inégale exposition aux risques.

Certaines pathologies illustrent aussi les angles morts de la recherche. Les fibromes sont plus fréquents et souvent plus sévères chez les femmes noires, mais les données françaises restent insuffisantes. Une politique de santé reproductive réellement universelle doit donc mieux représenter toutes les populations dans la recherche et donner davantage de moyens là où les pertes de chance sont les plus fortes.

Sources : Santé publique France, 7e rapport de l'Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, 2016-2018 ; Santé publique France, travaux sur la surmortalité maternelle des femmes immigrées.

NOS PROPOSITIONS

***Créer un observatoire des inégalités en santé reproductive**. Documenter et publier les écarts de délais, de diagnostic, de traitement, d'accès aux spécialistes, à l'AMP et aux maternités, ainsi que les résultats de santé maternelle et périnatale selon les territoires et les vulnérabilités sociales. Développer, dans le respect du droit et des libertés publiques, les outils permettant de mieux objectiver les discriminations.*

***Faire des territoires dits d'Outre-mer une priorité nationale de rattrapage en santé reproductive.** Fixer des objectifs de réduction des écarts avec l'Hexagone*

et consacrer des moyens humains et financiers dédiés à la santé maternelle et périnatale, à l'IVG, à l'AMP, au dépistage et à l'accès aux spécialistes.

Garantir l'égalité d'accès indépendamment du lieu de vie. *Organiser et prendre en charge transport, hébergement, orientation et télésuivi lorsqu'un accès à une maternité, un centre d'AMP ou une consultation spécialisée impose un déplacement important.*

Combattre les discriminations et les biais raciaux dans les soins*. Intégrer leur prévention à la formation initiale et continue des professionnel·les, mesurer l'expérience des patient·es et garantir des voies de signalement et de recours réellement accessibles.*

Rendre les parcours de santé reproductive réellement accessibles aux personnes en situation de handicap. *Garantir l'accessibilité physique des cabinets, centres de santé et équipements gynécologiques, obstétricaux et de dépistage ; développer une information accessible et adaptée ; former les professionnel·les au respect du consentement, de l'autonomie et de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.*

Faire entrer toutes les populations dans la recherche. *Veiller à ce que les cohortes, essais cliniques et priorités de recherche représentent suffisamment les populations ultramarines, migrantes et socialement exposées et documentent les pathologies insuffisamment étudiées, notamment les fibromes, sans transformer les catégories raciales en catégories biologiques.*

L'égalité en santé ne consiste pas à proposer exactement la même chose partout et à tout le monde. *Elle consiste à garantir à chacune et chacun la même chance d'être prévenu·e, diagnostiqué·e et soigné·e.*

REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement les élu·es ayant contribué à ce livret, ainsi que l'ensemble des associations et collectifs engagés pour faire progresser la santé reproductive et garantir l'accès de toutes et tous à leurs droits en matière de santé, notamment

Pr Mikaël Agopiantz, Président de l'Association Nationale du Don d'Engendrement (ANDDE)

Collectif BAMP

Dr Marina Kvaskoff, épidémiologiste et directrice de recherche Inserm

Camille Drouet Charles, Journaliste indépendante Autrice « Une grossesse sur quatre », La Revue Dessinée / Casterman,

Ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont préféré rester anonymes.

Pour suivre les actualités du mouvement, rendez-vous sur lesecologistes.fr

Pour rejoindre la campagne, rendez-vous sur marinetondelier.fr